



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LESÃO DE LCA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome: _____
Data de nascimento: ____/____/____ CPF: _____ RG: _____
Prontuário nº: _____ Telefone: _____
Endereço: _____
Representante legal (se aplicável):
Nome: _____
CPF: _____ Vínculo/parentesco: _____

2. MÉDICO RESPONSÁVEL / EQUIPE

Médico(a) responsável: _____ CRM: _____
Equipe auxiliar: _____

3. O QUE É O PROCEDIMENTO

O ligamento cruzado anterior (LCA) é uma das principais estruturas estabilizadoras do joelho, responsável por impedir o deslizamento anormal da tíbia em relação ao fêmur. Quando rompido, não cicatriza espontaneamente, sendo o tratamento, em regra, a RECONSTRUÇÃO CIRÚRGICA — e não a simples sutura. A cirurgia é realizada através de uma pequena incisão para retirada do enxerto e dentro do joelho através de VIDEOARTROSCOPIA (pequenas incisões com câmera e instrumentos dentro da articulação) e consiste na retirada dos restos do ligamento roto e na confecção de um NOVO ligamento a partir de um ENXERTO (tendão), que pode ser do próprio paciente (autoenxerto — em regra dos tendões flexores/“isquiotibiais”, do tendão patelar ou do quadricipital) ou, em casos selecionados, de banco de tecidos (aloenxerto). São perfurados TÚNEIS ÓSSEOS no fêmur e na tíbia, por onde o enxerto é posicionado e FIXADO com implantes (parafusos de interferência, botões ou similares), que podem ser metálicos ou absorvíveis.

4. INDICAÇÕES

Rotura do LCA com instabilidade do joelho (sensação de falseio/“o joelho sai do lugar”), sobretudo em pacientes ativos, praticantes de esportes ou cujas atividades exijam estabilidade articular, e quando há lesões associadas (meniscos, outros ligamentos) ou risco de novas lesões da cartilagem e dos meniscos, conforme avaliação ortopédica.

5. ANESTESIA

Raquianestesia (bloqueio espinal) e/ou anestesia geral, frequentemente associadas a bloqueio de nervos do membro (bloqueio femoral/adutor) para analgesia, conforme avaliação do anesthesiologista. A avaliação pré-anestésica e o esclarecimento dos riscos próprios da anestesia serão realizados por médico anesthesiologista, sendo objeto de termo de consentimento específico.

6. RISCOS GERAIS INERENTES A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Todo procedimento cirúrgico-anestésico, ainda que corretamente indicado e executado segundo a boa técnica médica, envolve riscos, que incluem, entre outros: sangramento e hemorragia, com eventual



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA

necessidade de transfusão de sangue e hemoderivados; infecção do sítio cirúrgico ou infecção sistêmica; reações adversas a medicamentos e reações alérgicas, inclusive graves (anafilaxia); fenômenos tromboembólicos (trombose venosa profunda e embolia pulmonar); lesão acidental de órgãos e estruturas vizinhas; deiscência (abertura) de suturas; cicatrização inadequada (cicatriz hipertrófica ou quelóide); necessidade de reintervenção cirúrgica; complicações cardiovasculares e respiratórias; e, em situações extremas e raras, óbito. A frequência e a gravidade dessas intercorrências variam conforme as condições clínicas de cada paciente (idade, doenças associadas, medicamentos em uso, hábitos como tabagismo, entre outras).

7. RISCOS, COMPLICAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS ESPECÍFICOS DESTES PROCEDIMENTOS

Além dos riscos gerais, este procedimento apresenta riscos, complicações e consequências que lhe são próprios, destacando-se:

- Infecção da ferida operatória e, mais grave, infecção dentro da articulação (artrite séptica), que pode exigir nova cirurgia (limpeza artroscópica), antibióticos prolongados e, raramente, retirada do enxerto;
- Falha, afrouxamento ou nova rotura do enxerto (re-ruptura), por trauma ou por integração inadequada, com possível necessidade de nova cirurgia (revisão);
- Rigidez articular e perda de amplitude de movimento (artrofibrose), podendo exigir fisioterapia intensiva e, eventualmente, nova intervenção para liberação;
- Trombose venosa profunda e embolia pulmonar (raras, porém graves);
- Lesão de nervos do joelho/perna, especialmente do nervo safeno, com dormência ou alteração de sensibilidade na face interna da perna (comum quando se usa o enxerto dos flexores), em regra permanente em pequenas áreas;
- Lesão de vasos sanguíneos (rara, porém grave);
- Dor na região de retirada do enxerto (morbidade da área doadora): dor na frente do joelho e ao ajoelhar-se (enxerto patelar) ou redução transitória da força de flexão (enxerto dos flexores); fratura da patela (rara, com enxerto patelar);
- Problemas relacionados aos implantes de fixação (dor, proeminência, soltura, reação ao material absorvível), podendo exigir sua retirada;
- Dor articular persistente, derrame (água no joelho) e estalidos;
- Instabilidade residual ou recidiva da frouxidão, com persistência da sensação de falseio;
- Lesão da cartilagem de crescimento em pacientes esqueleticamente imaturos (adolescentes), com risco de alteração do crescimento ósseo;
- Evolução, a longo prazo, para artrose do joelho, sobretudo quando há lesões associadas da cartilagem e dos meniscos;
- RESULTADO NÃO GARANTIDO: a cirurgia visa restaurar a estabilidade, mas não garante o retorno ao mesmo nível esportivo prévio, dependendo o resultado, de forma decisiva, da REABILITAÇÃO/FISIOTERAPIA.

8. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS

Tratamento conservador (não cirúrgico) com fisioterapia, fortalecimento muscular e modificação de atividades, indicado em pacientes de baixa demanda ou sem instabilidade significativa, assumindo-se o risco de episódios de falseio e de lesões secundárias dos meniscos e da cartilagem. A escolha do tipo de enxerto e do método de fixação foi-me explicada quanto a vantagens e desvantagens.



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA

9. CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS

Uso de órtese/imobilizador/muletas e controle da dor e do inchaço (gelo, elevação) conforme orientação, e realização regular da FISIOTERAPIA após a solicitação do médico, etapa indispensável ao sucesso da cirurgia. O retorno às atividades e ao esporte é progressivo e, em regra, leva de 6 a 12 meses. Sinais de alerta: febre, dor intensa e crescente, vermelhidão e secreção na ferida, inchaço importante e dor ou inchaço na panturrilha — procurar imediatamente o hospital.

10. ENXERTO, IMPLANTES E ACHADOS INTRAOPERATÓRIOS

Declaro estar ciente de que a escolha definitiva do tipo de enxerto e dos implantes de fixação poderá ser ajustada durante a cirurgia, conforme os achados e a qualidade dos tecidos, e AUTORIZO a equipe a adotar a melhor opção técnica disponível. Autorizo, ainda, o tratamento de lesões associadas eventualmente identificadas durante a artroscopia (meniscos, cartilagem ou outros ligamentos), no mesmo ato, no meu melhor interesse.

11. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

Nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD), declaro-me ciente de que o HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA. e a equipe assistente realizarão o tratamento dos meus dados pessoais e dados pessoais sensíveis (dados referentes à saúde) para as seguintes finalidades: (i) prestação da assistência à saúde e execução do procedimento ora consentido (tutela da saúde — art. 11, II, “f”, da LGPD); (ii) registro obrigatório em prontuário e sua guarda pelos prazos legais (Lei nº 13.787/2018); (iii) faturamento junto a operadoras de planos de saúde ou ao Sistema Único de Saúde, quando aplicável; e (iv) cumprimento de obrigações legais e regulatórias perante autoridades sanitárias e conselhos profissionais. O tratamento observará os princípios da finalidade, adequação, necessidade e segurança, sendo vedado o compartilhamento dos meus dados com terceiros para fins comerciais. Estou ciente de que posso exercer os direitos previstos no art. 18 da LGPD (confirmação do tratamento, acesso, correção, informação sobre compartilhamentos, entre outros) mediante solicitação dirigida ao hospital ou ao seu Encarregado de Proteção de Dados (DPO), pelos canais de atendimento da instituição.

12. AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES SOROLÓGICOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO

Declaro estar ciente de que, durante a assistência à minha saúde, os profissionais da equipe (médicos, equipe de enfermagem e demais colaboradores) estão sujeitos a acidentes com exposição a material biológico — tais como acidentes com agulhas e instrumentos perfurocortantes, ou contato de sangue e fluidos corporais com mucosas e pele não íntegra.

Nessa hipótese, e exclusivamente para a proteção da saúde do profissional acidentado e a adequada conduta médica (avaliação da necessidade de profilaxia pós-exposição, acompanhamento e adoção das medidas cabíveis), **AUTORIZO** que seja colhida amostra do meu sangue e realizados, às expensas do hospital, os seguintes exames sorológicos, na condição de paciente-fonte:

- Anti-HIV (vírus da imunodeficiência humana);
- HBsAg e Anti-HBc (Hepatite B);
- Anti-HCV (Hepatite C);
- VDRL / sorologia para sífilis;
- e, quando clinicamente indicado, Anti-HTLV I/II e demais exames pertinentes ao caso, conforme protocolo institucional e as normas do Ministério da Saúde.



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA

Estou ciente de que: (i) a coleta ocorrerá apenas se efetivamente sobrevier o acidente com exposição a material biológico; (ii) os resultados serão tratados com confidencialidade, nos termos da LGPD, integrarão o meu prontuário e me serão comunicados, com a devida orientação e encaminhamento médico, caso qualquer exame se mostre alterado; (iii) os exames têm finalidade exclusivamente assistencial e de segurança ocupacional, não podendo ser utilizados para qualquer forma de discriminação; e (iv) esta autorização não acarreta qualquer custo para mim.

13. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

DECLARO que:

- a) li este termo (ou ele me foi lido), redigido em linguagem clara e acessível, e compreendi integralmente as informações nele contidas;
- b) fui informado(a), de forma compreensível, sobre o diagnóstico, a natureza e os objetivos do procedimento, seus benefícios, riscos, complicações possíveis, consequências e alternativas, inclusive a de não realizá-lo;
- c) tive oportunidade de fazer perguntas, e todas as minhas dúvidas foram respondidas de forma satisfatória;
- d) estou ciente de que a medicina não é ciência exata e de que a obrigação assumida pela equipe é de meio — emprego diligente dos melhores recursos e técnicas disponíveis — e não de resultado, não havendo garantia de êxito ou de resultado específico;
- e) autorizo a equipe médica a realizar os procedimentos adicionais que se mostrem necessários durante o ato cirúrgico, diante de situações imprevistas, para a proteção da minha vida e da minha saúde;
- f) comprometo-me a seguir as orientações pré e pós-operatórias e declaro ter informado corretamente meus antecedentes de saúde (alergias, medicamentos em uso, cirurgias e doenças prévias);
- g) autorizo o encaminhamento de peças, tecidos ou materiais retirados durante o ato cirúrgico para exame anatomopatológico e seu descarte conforme as normas sanitárias, quando aplicável;
- h) estou ciente do meu direito de revogar este consentimento a qualquer momento antes da realização do procedimento, sem sofrer qualquer penalização ou prejuízo ao meu atendimento;
- i) recebi cópia deste termo.

Assim, de forma LIVRE, CONSCIENTE e ESCLARECIDA, **AUTORIZO** a realização do procedimento **RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LESÃO DE LCA)**, pela equipe acima identificada, nas dependências do Hospital das Clínicas de Mineiros Ltda.

Mineiros/GO, _____ de _____ de 20____.

PACIENTE

Nome e assinatura

REPRESENTANTE LEGAL (se aplicável)

Nome, CPF e assinatura



HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA

DECLARAÇÃO DO MÉDICO

Declaro que expliquei ao(à) paciente e/ou ao seu representante legal, em linguagem clara e adequada ao seu grau de compreensão, a natureza do procedimento acima identificado, seus objetivos, benefícios, riscos, complicações possíveis e alternativas, respondendo às perguntas formuladas e certificando-me da compreensão das informações, nos termos do Código de Ética Médica e da Recomendação CFM nº 1/2016.

MÉDICO(A) RESPONSÁVEL

Nome, assinatura e carimbo — CRM

TESTEMUNHA 1

Nome, CPF e assinatura

TESTEMUNHA 2

Nome, CPF e assinatura

REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO

Declaro que, nesta data, REVOGO, por minha livre vontade, o consentimento anteriormente prestado para a realização do procedimento identificado neste termo, estando ciente das possíveis consequências da não realização, que me foram devidamente explicadas pela equipe médica.

Mineiros/GO, _____ de _____ de 20____.

PACIENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Nome, CPF e assinatura

MÉDICO(A) / PROFISSIONAL QUE RECEBEU A REVOGAÇÃO

Nome, assinatura e carimbo